

GEBELİKTE HİPERTANSİYF HASTALIKLAR

TUS Açısından Yüksek Getirili 12 Başlık

1 Gebelik haftası

<20 hafta → kronik HT
≥20 hafta → gestasyonel HT /
preeklamps

2 Preeklamps

HT + proteinüri
veya
HT + maternal organ disfonksiyonu
→ Preeklamps

Proteinüri zorunlu değil.

3 Ciddi HT

≥160 sistolik VEYA ≥110 diyastolik
→ akut antihipertansif tedavi

Bu eşik özellikle ezberlenmeli.

4 Akut antihipertansifler

Labetalol
Hidralazin
Immediate-release nifedipin

5 Eklamps

Preeklamps + nöbet
→ MgSO₄

6 Mg toksisitesi

Hiporefleksi → solunum depresyonu
→ Ca glukonat

7 HELLP

Hemolysis
Elevated **L**iver enzymes
Low **P**latelets

8 Süperempoze preeklamps

Kronik HT
+ yeni preeklampitik bulgular
→ süperempoze preeklamps

9 Fetal sonuç

Preeklamps
→ uteroplental yetmezlik
→ FGR

10 Profilaksi

Yüksek riskli gebede → düşük doz
aspirin

ACOG/SMFM yaklaşımında 81 mg/gün
aspirin, yüksek riskli kadınlarda 12-28.
haftalar arasında, tercihen 16. haftadan
önce başlanır.

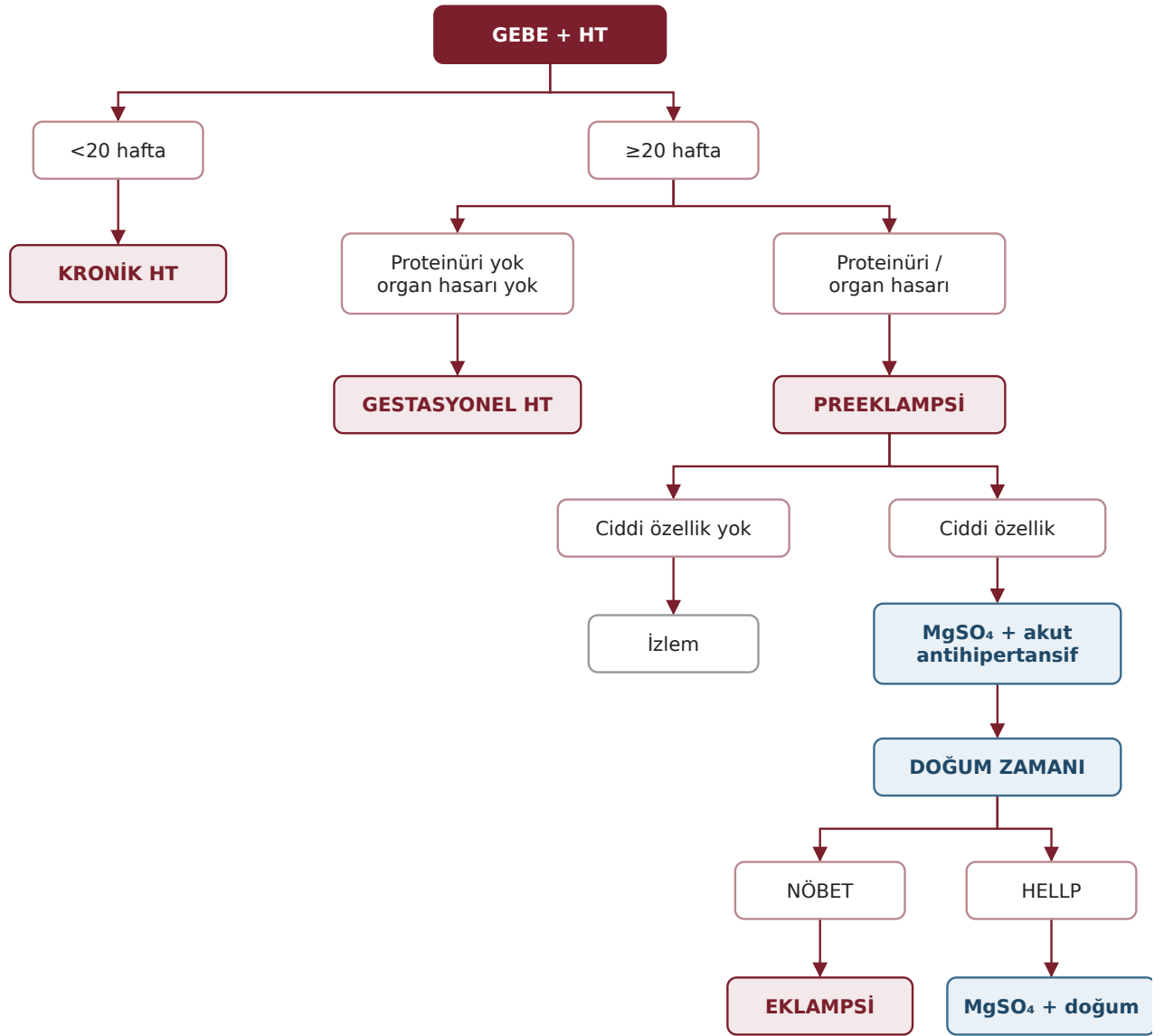
11 Gebelikte verilmemesi gerekenler

ACE inhibitörü
ARB
→ gebelikte kullanılmaz.

12 Doğum kararı

Özellikle ciddi özelliklerin varlığı doğum
kararının temel belirleyicisidir.

TUS Algoritması



5 TUS Cümlesi

1 <20 hafta HT → kronik HT

2 HT + proteinüri veya organ disfonksiyonu → preeklampsi

3 $\geq 160/110$ → acil antihipertansif

4 Nöbet → MgSO₄

5 Hemoliz + $\uparrow$ AST/ALT + $\downarrow$ PLT → HELLP